SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

NÚCLEO DE GOVERNANÇA CLÍNICA

Tipo do documento	**Protocolo Assistencial**	**PPTF/SAS:39**	**Versão:01**
		Pág.: 1-30	
Título do documento	**PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS**	**Data de emissão: 26/09/2023**	
		Revisão: sob demanda	

1. INTRODUÇÃO

As feridas são problemas de saúde pública no Brasil podendo ser classificadas não só ruptura de pele, mas também como lesões de músculos, tendões e ossos. Existem inúmeras pessoas com patologias que acometem a integridade da pele como Diabetes, hanseníase, flebites varizes entre outros casos agudos de queimaduras e infecções cirúrgicas (Sociedade Brasileira de Hansenologia, 2016).

Atualmente o avanço do tratamento de feridas disponibiliza métodos terapêuticos modernos, capaz de prevenir complicações e auxiliar na reparação celular. Reconhecer a complexidade da feridas e o tratamento adequado é um desafio para profissionais, uma vez que as fases de reparação celular são diferentes, e a seleção adequada e o uso adequado de cobertura especiais são cruciais para eficácia do tratamento.

Os curativos podem ser classificados conforme composição; passivo e com princípio ativo, curativos inteligentes, curativos biológicos e compostos. Os manejos inadequados dessas tecnologias podem ser prejudiciais a no leito das feridas, comprometendo o reestabelecimento da saúde do paciente e custos altos para o serviço público.

Este protocolo é direcionado para profissionais da rede pública de saúde de Aparecida de Goiânia, para orientar o manejo adequado dos principais tipos de feridas.

2. OBJETIVO

Padronizar o manejo adequado tratamento de feridas agudas e crônicas para profissionais da rede municipal de Saúde Aparecida de Goiânia, diminuindo o número de internações por complicações de feridas em 30% a partir da implantação do protocolo.

2.1 OBJETIVO ESPECIFICO

- Classificar os tipos de feridas mais comuns;
- Apresentar os tipos de coberturas;
- Aumentar o acesso aos pacientes nos serviços de atenção primária;
- Orientar o atendimento ao tratamento de feridas na rede de atenção e o funcionamento das unidades de saúde;
- Orientar fluxo de atendimento e encaminhamento para especialidades

3. ANATOMIA E FISIOLOGIA DA PELE

A pele é o maior órgão humano: um adulto é revestido por aproximadamente 2m² de pele, com aproximadamente 2 mm de espessura, o que representa cerca 15% do peso corporal.

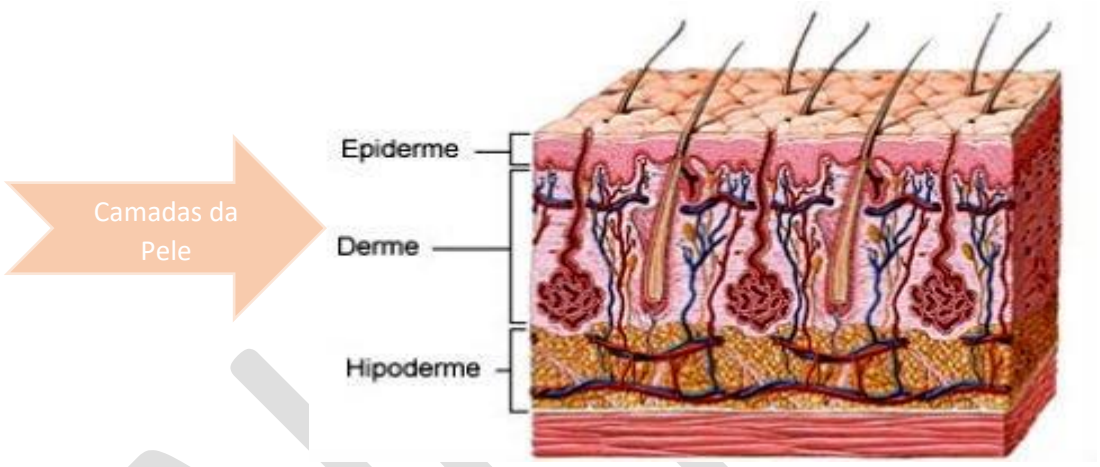
É formada por duas camadas primárias e uma camada de gordura subcutânea, cada camada com características e funções diferentes: derme, epiderme e a hipoderme subcutânea, além de órgãos anexos como folículos pilosos, glândulas sudoríparas, sebáceas e unhas.

A) EPIDERME (1ª camada): é a camada mais externa da pele e consiste primariamente em queratinócitos, que a impermeabilizam. A epiderme está em constante renovação, as células mais antigas são substituídas por outras mais novas em uma renovação que ocorre em média a cada 12 dias.

B) DERME (2ª camada): localizada entre a epiderme e a hipoderme, a derme é formada por tecido conjuntivo que contém fibras protéicas, vasos sanguíneos e

linfáticos, terminações ervosas, órgãos sensoriais e glândulas. As fibras são produzidas por células chamadas fibroblastos, que permitem a elasticidade, tração e conferem maior resistência à pele.

C) HIPODERME (3ª camada): a última camada da pele é basicamente formada por células de gordura e faz conexão entre a derme e a fáscia muscular; atuando como reservatório energético, isolante térmico, proteção contra-choques mecânicos, fixação dos órgãos e modelando a superfície corporal.



4. AS FUNÇÕES DA PELE

A pele desempenha um grande número de funções vitais, destacando-se a proteção das estruturas internas, percepção sensorial, regulação da temperatura corporal, excreção, metabolismo e absorção:

FUNÇÕES DA PELE

- Força e elasticidade ↑ regeneração;
- Resiste à perda de água e eletrólitos;
- Responsável pela produção de Vitamina D;
- Secreção e Excreção;
- Protege contra agentes químicos, físicos e biológicos;
- Recebe estímulos sensoriais externos;
- Armazenagem de nutrientes (lipídios, água, vitaminas etc);
- Imunorregulação;
- Promove estímulo visual, olfatório e tátil;

- Interligada com o metabolismo do corpo humano, refletindo alterações sistêmicas

5. CLASSIFICAÇÃO DAS FERIDAS

As feridas são classificadas segundo diversos parâmetros, que auxiliam no diagnóstico, evolução e definição do tipo de tratamento, tais como cirúrgicas,traumáticas e ulcerativas.

a) CIRÚRGICAS – provocadas por instrumentos cirúrgicos, com finalidade terapêutica, podem ser:

- Incisivas: perda mínima de tecido;
- Excisivas: remoção de

b) TRAUMÁTICAS – feridas provocadas acidentalmente por agentes:

- Mecânicos: como um prego, espinho ou por pancadas;
- Físicos: como temperatura, pressão, eletricidade;
- Químicos: ácidos ou soda cáustica, por exemplo

c) ULCERATIVAS – lesões escavadas, circunscritas, com profundidade variável, podendo atingir desde camadas superficiais da pele até músculos. As úlceras são classificadas conforme as camadas de tecido atingido seguindo os seguintes estágios.

5.1 ESTÁGIOS DE FERIDAS

Estágio I: pele avermelhada, não rompida, mácula eritematosa bem delimitada, atingindo epiderme;

Estágio II: pequenas erosões na epiderme ou ulcerações na derme. Apresenta-se normalmente com abrasão ou bolha;

Estágio III: afeta derme e tecido subcutâneo;

Estágio IV: perda total da pele atingindo músculos, tendões e exposição.

6. MORFOLOGIA DA FERIDA

A morfologia descreve e detalha a localização, dimensões, números e profundidade das feridas.

a) **Quanto à localização**: as feridas ulcerativas frequentemente acometem usuários que apresentam dificuldades de deambulação. Áreas de risco para pessoas que passam longos períodos sentados:

- Tuberosidades isquiáticas;
- Pés;
- Espinha dorsal torácica;
- Calcanhares.

b) Áreas de risco para quem passa longos períodos acamado:

- Região sacrococcígea;
- Tornozelos;
- Região trocantérica, Calcanhares; isquiática espinha ilíaca;
- Cotovelos;
- Joelhos (face anterior, Espinha dorsal; medial e lateral);
- Cabeça (região occipital e orelhas).

c) Quanto às dimensões: Extensão da ferida em área = cm²;

- Pequena: menor que 50cm²;
- Média: maior que 50cm² e menor que 150cm² ;

- Grande: maior que 150cm² e menor que 250cm²;
- Extensão: maior que 250cm²

c) Quanto ao número: existindo mais de uma ferida no mesmo membro ou área corporal com distância mínima de 2cm entre elas, faça a somatória.

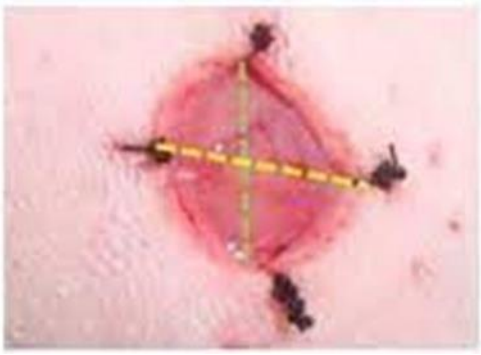
d) Quanto à profundidade:

- **Feridas planas ou superficiais**: envolvem a epiderme, derme e tecido subcutâneo;
- **Feridas profundas**: envolvem tecidos moles profundos, tais como músculos e fáscia;
- **Feridas cavitárias;** caracterizam-se por perda de tecido e formação de uma cavidade com envolvimento de órgãos ou espaços. Podem ser traumáticas, infecciosas, por pressão ou complicações pós-cirúrgica.

e) Mensuração: avalia comprimento x largura x profundidade.

- **Medida simples:** mensurar uma ferida medindo-a em seu maior comprimento e largura, utilizando uma régua em centímetros (cm). É aconselhável associá-la à fotografia. Pode ser usada espátula estéril, seringa de insulina sem agulha
- **Medida cavitária:** após a limpeza da ferida, preencher a cavidade com SF 0.9%, aspirar o conteúdo com seringa estéril e observar o valor preenchido em milímetros. Outra técnica utilizada é através da introdução de uma espátula ou seringa estéril na cavidade da ferida, para que seja marcada a profundidade. Após, verificar o tamanho com uma régua.

Exemplos de mensuração de feridas



7. CARACTERÍSTICAS DO LEITO DA FERIDA

As características do leito da ferida podem apresentar;

a) **Granulação**: de aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido, ricamente vascularizado;

b) **Epitelização:** revestimento novo, rosado e frágil. Os tecidos inviáveis compreendem:

c) **Necrose de coagulação (escara**): caracterizada pela presença de crosta preta e/ou bem escura;

d) **Necrose de liquefação (amolecida):** tecido amarelo-esverdeado e/ou quando a lesão apresenta infecção, secreção purulenta;

e) **Desvitalizado ou Fibrinoso**: tecido de coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida e se apresenta como cordões ou crostas grossas, podendo ainda ser mucinoso.

Infecção

Fibrina

Granulação

Epitelização

Necrose

6. FERIDAS CRÔNICAS E TEMPO DE CICATRIZAÇÃO

A ferida aguda é quando há ruptura da vascularização com desencadeamento imediato do processo de hemostasia. Se a ferida não fechar até **3 semanas** após a ruptura da pele, a contração cessa, caracterizando então a ferida **como crônica**.

Ferida crônica é quando há desvio na sequência do processo cicatricial fisiológico. A inflamação crônica pode resultar em um longo processo de cura e evoluir com resposta muito diferente das manifestações clássicas da inflamação aguda.

É importante sabermos reconhecer as 3 fases da cicatrização para que possamos implementar o cuidado correto com a ferida.

a) Fase de inflamação ou exsudativa (limpeza) – a primeira fase de hemostasia e inflamação iniciam-se com a ruptura de vasos sanguíneos e o extravasamento de sangue. Durante este processo ocorre o recrutamento de macrófagos e neutrófilos, ou seja, ocorre reação completa do tecido conjuntivo vascularizado em resposta à agressão do tecido, cujo objetivo é interromper a causa inicial (dor, calor rubor e edema).

b) Fase proliferativa (granulação e reepitelização) – caracteriza-se pela neovascularização e proliferação de fibroblastos, com formação de tecido róseo, mole e granular na superfície da ferida (3 a 4 dias).

c) Fase de maturação ou remodelagem do colágeno: é a fase final de cicatrização de uma ferida, caracterizada pela redução e pelo fortalecimento da cicatriz. Durante esta fase, a cicatriz se contrai e torna-se pálida e a cicatriz madura se forma 3 semanas a 1 ano a mais.

7. TIPOS DE CICATRIZAÇÃO

As feridas são classificadas pela forma como se fecham. Uma ferida pode se fechar por intenção primária, secundária ou terciária.

- **1ª intenção ou primária:** a cicatrização primária envolve a reepitelização, na qual a camada externa da pele cresce fechada. As feridas que cicatrizam por primeira intenção geralmente são feridas superficiais, agudas, que não tem perda de tecido, resultados de queimaduras de primeiro grau e cirúrgicas em cicatriz mínima, por exemplo. Levam de 4 a 14 dias para fechar;

● **2ª intenção ou secundária**: é uma ferida que envolve algum grau de perda de tecido. Podem envolver o tecido subcutâneo, o músculo, e possivelmente, o osso. As bordas desta ferida não podem ser aproximadas. Geralmente são feridas crônicas, como úlceras. Existe um aumento do risco de infecção e demora à cicatrização, uma vez que ela ocorre de dentro para fora. Resultam em formação de cicatriz e têm maior índice de complicações do que as feridas que se cicatrizam por primeira intenção;

● **3ª intenção ou terciária**: ocorre quando a ferida é mantida aberta intencionalmente, para permitir a diminuição ou redução do edema ou infecção. Outra possibilidade é permitir a remoção do exsudato através da drenagem, como em feridas cirúrgicas, abertas e infectadas, com drenos.

8. MÉTODOS DE DESBRIDAMENTO

a) **Instrumental, conservador e cirúrgico**: utilizam-se materiais cortantes como tesouras, lâminas de bisturis e outros, realizado por médicos ou enfermeiros capacitados. É indicado para remover grande quantidade de tecidos ou em extrema urgência, com incisões em tecidos vivos, e na tentativa de transformar feridas crônicas em feridas agudas.

b) **Mecânico:** o desbridamento mecânico envolve curativos úmidos a secos, usados normalmente em feridas com excesso de tecido necrótico e secreção mínima. Exige a realização de técnica apropriada e o material usado no curativo é fundamental ao seu desfecho. Também funciona por fricção, irrigação e hidroterapia.

c) **Autolítico:** é através de um processo fisiológico, o qual o ambiente é mantido úmido estimulando enzimas auto-digestivas do corpo. Embora este processo seja mais demorado, não é doloroso, é de fácil realização e é apropriado para usuários que não toleram outro método. Se a ferida estiver infectada, o desbridamento autolítico não é a melhor opção terapêutica.

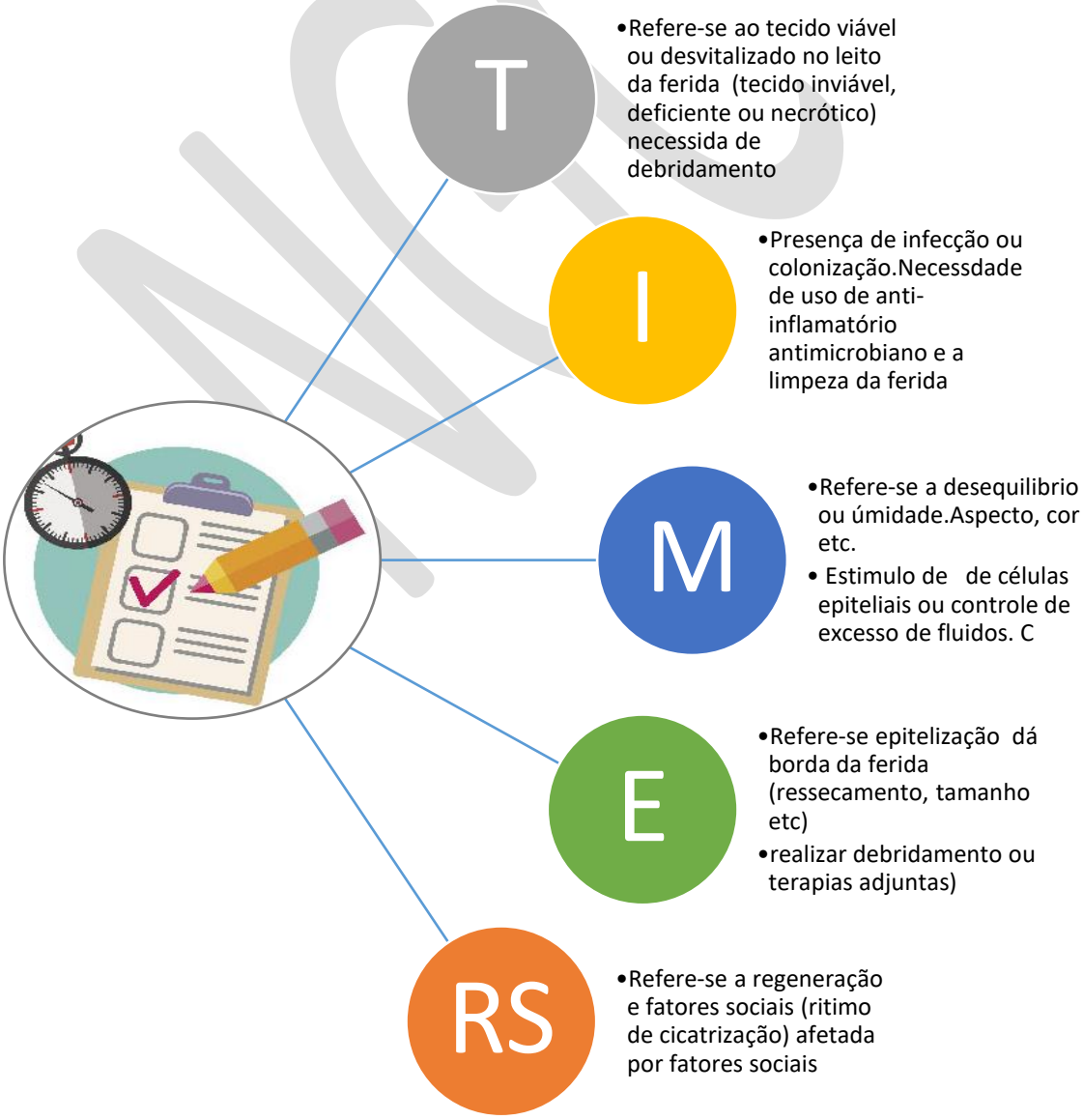
d) **Químico:** o desbridamento químico com agentes enzimáticos é um método seletivo de desbridamento. As enzimas são aplicadas topicamente nas áreas de tecido necrótico, fragmentando os elementos de tecido necrótico. As enzimas digerem somente o tecido necrótico e não agridem o tecido saudável. Estes agentes exigem condições específicas que variam com o produto, ou seja, o método deve seguir as

orientações do fabricante. A aplicação das enzimas deve ser interrompida assim que a ferida estive limpa e com tecido de granulação favorável.

9. AVALIAÇÃO DAS FERIDAS

Na consulta de enfermagem, o reconhecimento dos tipos de feridas é indispensável para que o profissional classifique a localização; estágio; etiologia; tamanho; coloração; característica; presença de exsudato odor; estado nutricional do paciente.

O enfermeiro deverá realizar anamnese do paciente e do leito da ferida adotando, adotando a ferramenta do Acrônimo TIMERS que apoia os profissionais nas tomadas de decisões. Possui como significado as palavras inglesas: tissue (tecidos inviáveis), infection (infecção), moisture (umidade ou exsudato), edge (bordas da lesão), regeneration (Regeneração ou Reparação), social factor (fator social).



As informações do leito da ferida devem ser relatadas no prontuário eletrônico (PEC) seguindo as descrições do acrônimo TIMERS. Para fins de padronização de registro no prontuário eletrônico foi padronizado um roteiro que deverá ser inserido no prontuário Eletrônico (PEC) selecionando e Ctrl+C (copia) e Ctrl+V (cola) marcando com "X" a característica da ferida da avaliação (ANEXO 2).

9.1 AVALIAÇÃO DE FERIDAS COM ASPECTO INFECCIOSO

O reconhecimento da ferida com aspecto infeccioso, tem por objetivo adequar o tratamento e melhorar a cicatrização (infecção local, infecção disseminada/profunda e infecção sistêmica). E, para essa abordagem será adotada a ferramenta "NERDS" e "STONES" conforme quadro abaixo.

Infecção do compartimento superficial (colonização crítica)	Infecção do compartimento profundo
Nohealing (não cicatrização da ferida	Size (aumento da ferida)
Exsudate wound (ferida com exsudato)	Aumento da temperatura
Red and bleeding wound (tecido de granulação vermelho	A extensão da ferida ao boné (osso)
Debris om the Wound (detritos de tecidos)	Deteriorização da nova ferida/Exsudato/edema/eritema
Smell from the wound (cheiro)	Smell/cheiro/odor

Quadro 1-Apdtado ***IDENTIFICATION AND TREATMENT OF INFECTION ON COMPLEX WOUNDS, 2012***

Quando o profissional de enfermagem, julgar necessidade poderá encaminhar ao médico assistente para intervenção e uso de antimicrobiano sistêmico.

10. RESPONSABILIDADE DO ENFERMEIRO

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº578/2018 nº Art. 1º que aprova o regulamenta a atuação da Equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, atribuindo a equipe de enfermagem autonomia na assistência da pessoa com feridas.

È responsabilidade da equipe de enfermagem:

- Realizar avaliação da ferida e registro no prontuário;

- Realizar limpeza concorrente da sala de curativo, no início do dia, bem como manter sala higienizada e organizada;
- Verificar a data de validade, bem como a integridade e vedação dos materiais esterilizados;
- Realizar reposição de materiais necessários para o funcionamento das salas conforme fluxo estabelecido pela central de distribuição de medicamentos municipais
- Solicitar em tempo hábil coberturas especiais para assistência do paciente seguindo o fluxo estabelecido de solicitação pelo link https://forms.gle/pcPbHyjDRxSag9ms8 (anexo 1);
- Aprazar data de retorno do paciente para troca de curativos;
- Manter a sala de curativos organizada após cada procedimento;
- Encaminhar para o profissional médico e/ou equipe multidisciplinar quando paciente apresentar sinais de agravamento

11. TRATAMENTO

O tratamento adequado é de acordo com cada estado e etiologia da ferida e deverá seguir os seguintes passos:

Avaliação
- Avaliação do tipo de ferida (etiologia) aspecto, presença de infecção/exsudato, mensurar o tamanho e profundidade;

Limpeza
- Remoção de tecido desvitalizado;debritamento com bisturi, enzimático ou mecânico;

Preparo
- Preparo ao redor da pele na área ao redor da lesão (peri-lesional) para promover a aderência do curativo e proteger a pele saudável (se necessário, faça uso do protetor cutâneo);

Cobertura
- Selecione os curativos primários e secundários adequados: faça as seleções de curativos com base na profundidade da ferida (parcial x espessura total), condição da pele ao redor do leito da ferida, grau de colonização, quantidade de exsudato e o tamanho da ferida.

Retorno
- Aprazar o retorno do paciente para continuidade do tratamento

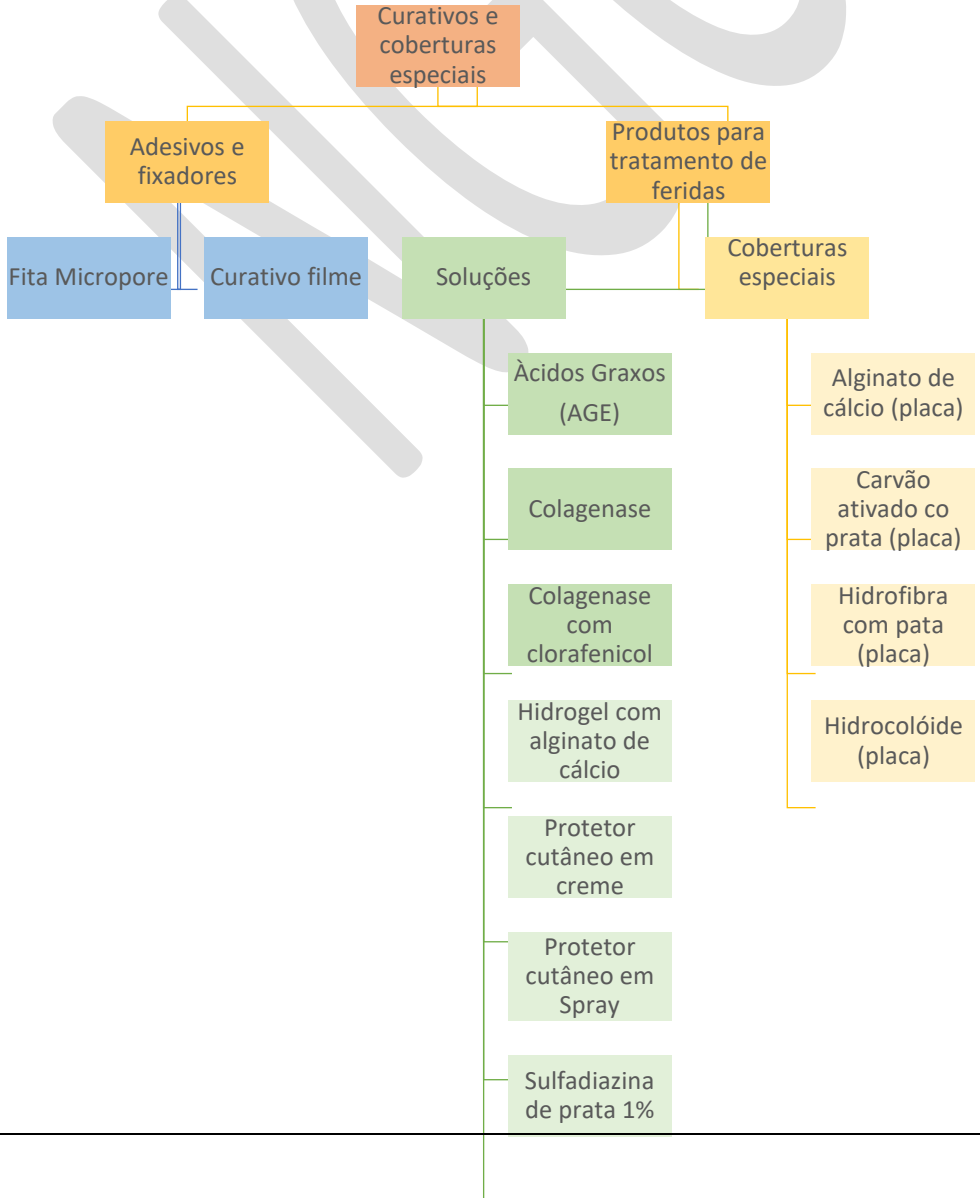
12. COBERTURAS DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

A seleção do tipo de cobertura vai depender do tipo de tipo de ferida e da evolução das fases de cicatrização. Os tipos de coberturas podem ser classificados:

- Passivo: Somente protegem e cobrem as feridas (gases, ataduras);
- Interativos: Proporcionam um micro-ambiente ótimo para a cura da ferida;
- Bioativos: Resgatam ou estimulam a liberação de substâncias durante o processo de cura.

Os produtos essenciais para o tratamento de feridas agudas e crônicas nas unidades de saúde e serviços ofertados na rede de atenção do município estão agrupados em subgrupos gerais e específicos conforme esquema abaixo:

COBERTURAS ESPECIAIS DISPONÍVEIS



Fonte: Apdtado da Relação de Materiais Médico Hospitalares do município de Aparecida de Goiânia (REMAT 2023).

As unidades de saúde devem receber o paciente realizar o primeiro atendimento independente de disponibilidade de cobertura especial, ou seja, caso a unidades não tenha o produto no momento, o profissional deverá realizar a limpeza e aprazar para chegada do material.

A solicitação de coberturas especiais deverá ser pelo link: https://forms.gle/pcPbHyjDRxSag9ms8. Caso ocorra atraso, o profissional deverá informar o gestor para entrar em com o Almoxarifado de Medicamentos via e-mail: curativosaparecida@gmail.com ou contato telefônico:(62) 3545-4850 dás 08:00 ás 17:30 de segunda a sexta.

NGC

TIPOS DE COBERTURAS

TIPO DE MATERIAL	INDICAÇÃO	MECANISMO DE AÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO	PERÍODO DE TROCA
GAZE COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% (SF)	✓ Contribuir para a umidade da lesão; ✓ Proteger o tecido;	Contribuir para a umidade da lesão, favorece a formação de tecido de granulação, estimula o desbridamento autolítico/mecânico e absorve exsudato.	✓ Feridas que cicatrizam por primeira intenção; ✓ Lesões com excesso de exsudato e secreção purulenta; ✓ Locais de inserção de cateter; ✓ Drenos; ✓ Fixador externo	O curativo deve ser trocado toda vez que estiver saturado com a secreção ou, no máximo, a cada 24 horas. Quando na presença de pouco exsudato, a gaze deverá ser umedecida duas a três vezes ao dia, com SF0,9%.
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL – AGE	✓ Tratar feridas abertas vitalizadas, não infectadas, em fases de granulação e epitelização (com ou sem exsudato); ✓ Proteção da pele peri-lesão; ✓ Prevenção de úlcera por Pressão;	Proteger a ferida preservando o tecido vitalizado e mantendo meio úmido proporcionando nutrição celular local. Acelera o processo de granulação tecidual. Evita a aderência ao leito da lesão e em lesões exsudativas atua como proteção de borda da lesão.	✓ tecidos desvitalizados, hipergranulação, lesões infectadas, feridas oncológicas,	O curativo deve ser trocado toda vez que estiver saturado com a secreção ou, no máximo, a cada 24 horas
	✓ Tecidos desvitalizados, hipergranulação, lesões infectadas,	Proteger a ferida preservando o tecido vitalizado e mantendo meio úmido proporcionando nutrição celular local. Acelera o	✓ Lesões infectadas e queimaduras de 3º ou 4º grau. ✓ Feridas muito exsudativas ✓ Feridas cavitárias.	O curativo deve ser trocado toda vez que estiver saturado com a secreção ou, no máximo, a cada 24 horas.

HIDROCOLÓIDE DE PLACA	feridas oncológicas;	processo de granulação tecidual. Evita a aderência ao leito da lesão e em lesões exsudativas atua como proteção de borda da lesão	✓ Região sacra em caso de incontinência fecal e urinária;	
HIDROGEL <u>SEM</u> ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	✓ Feridas abertas com tecido vitalizado ou desvitalizado; ✓ Queimaduras de 2º e 3º grau; ✓ Úlceras venosas e lesão por pressão.	Possibilitar um ambiente úmido que promove o desbridamento autolítico, estimulando a cicatrização.	✓ Pele íntegra; ✓ Feridas operatórias fechadas; ✓ Feridas muito exsudativas; ✓ Fístulas.	Quando utilizado com gaze como cobertura troca a cada 24h. Pode permanecer por até 7 dias quando associado com algumas coberturas como por exemplo hidrocolóide ou hidrofibra. Feridas infectadas troca no máximo a cada 24h. Feridas com necrose troca no máximo cada 72h.
	✓ Feridas abertas com tecido vitalizado ou desvitalizado; ✓ Queimaduras de 2º e grau; ✓ Úlceras venosas e lesão por pressão.	Possibilitar um ambiente úmido que promove o desbridamento autolítico, estimulando a cicatrização. E também promove hemóstese e absorção do exsudato.	✓ Pele íntegra; ✓ Feridas operatórias fechadas; ✓ Feridas muito exsudativas; ✓ Fístulas; ✓ Queimaduras de 3º grau;	Quando utilizado com gaze como cobertura troca a cada 24hs. Pode permanecer por até 7 dias quando associado com algumas coberturas como por exemplo

HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO			✓ Lesões com exposição de tendões e ossos.	hidrocolóide ou hidrofibra. Feridas infectadas troca no máximo a cada 24hs. Feridas com necrose troca no máximo cada 72hs.
HIDROFIBRA COM PRATA (AG)	✓ Feridas com exsudato moderado a alto, feridas cavitárias e altamente colonizadas ou infectadas.	Auxiliar o desbridamento osmótico autolítico ao manter o meio úmido, induz hemostasia, possui alta capacidade de absorção de exsudato e sua retirada é atraumática preservando o tecido vitalizado. É bactericida e fungicida. Mantém atividade antimicrobiana através da liberação controlada da prata.	✓ Feridas com pouca exsudação e uso limitado em feridas superficiais; ✓ Feridas com necrose seca ou tecido inviável; ✓ Hipersensibilidade a prata	Trocar curativo secundário quando saturado ou em até 24 horas. A placa de hidrofibra poderá permanecer na ferida por até 7 dias. Nos casos de queimadura 2º grau a hidrofibra com AG pode permanecer até 14 dias na ferida. Nestes casos recortar a hidrofibra que se desprende da pele ao redor da ferida conforme a epitelização do tecido.
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO	✓ Feridas exsudativas e infectadas, com ou sem odor;	Neutralizar o odor através do mecanismo de adsorção. A prata exerce ação bactericida.	✓ Hipersensibilidade a prata; ✓ Feridas com sangramento;	O curativo pode permanecer até 7 dias. As trocas ocorrem em média de

COM PRATA (RECORTÁVEL)			✓ Aplicação direta em tumor; ✓ Feridas limpas e secas	3 a 7 dias dependendo da capacidade de adsorção. Trocar a cobertura secundária sempre que estiver saturada.
CREME DE SULFADIAZINA DE PRATA	✓ Priorizado para tratamento de queimaduras.	Atuar contra uma grande variedade de microorganismos, como: bactérias gram-negativas e positivas, fungos, vírus e protozoários. O uso indiscriminado da sulfadiazina de prata causa citotoxicidade e pode levar à resistência microbiana. Raramente as bactérias são eliminadas pelos antibióticos tópicos, devido à proteção da capa fibrinosa na superfície ulcerada e algumas espécies bacterianas são capazes de produzir um "biofilm" protetor que dificulta a ação do antibiótico. Tecidos desvitalizados ou necróticos, espaços mortos, coleções serosas e	Presença de hipersensibilidade aos componentes; disfunção renal ou hepática, leucopenia transitória, raríssimos casos de hiposmolaridade, raríssimos episódios de aumento da sensibilidade à luz solar. Mulheres grávidas, crianças menores de dois meses de idade e recém-nascido prematuro, devido ao risco de Kernicterus, causado pelo bilirrubinemia.	As trocas deverão ser feitas conforme a saturação das gazes ou no período máximo de 24 horas.

		sanguíneas também bloqueiam a ação dos antibióticos. Tais fatos permitem afirmar que antibioticoterapia sistêmica é a mais adequada para tratar feridas infectadas.		
COLAGENASE	✓ Feridas com tecido desvitalizado.	Degradar o colágeno nativo da ferida, contribuindo na formação de tecido novo	Feridas com cicatrização por 1° intenção; usuários sensíveis ao produto.	Necrose: no máximo a cada 72 horas. Outros casos: a cada 24 horas
CREME BARREIRA	✓ O Creme Barreira é o tratamento ideal para a pele seca ou irritada, causada pelo exsudato oriundo da pele perilesional. O Creme Barreira repele a entrada de líquidos Ele suaviza a pele, contém um protetor de pH que restaura o pH da pele, prevenindo lesões cutâneas	Proteger a pele ao redor da ferida exposta ao exsudato		

SPRAY BARREIRA	✓ Ardor de pele causados por efluentes adesivos	Proteger contra potenciais lesão de pele.		
COLAGENESE COM CLORAFENICOL	✓ Tecidos desvitalizados; ✓ Lesões superficiais;	Conter as infecções bacterianas locais que, secundariamente, podem estar presentes.		
CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL	✓ Cobertura primária e secundária; ✓ Prevenção de lesão por pressão; ✓ Feridas cirúrgicas e fixação de acessos venosos; ✓ Queimadura		Alérgico a componentes	
FITA HIPOARLEGÊNICA	✓ Pele sensível;	Permitir a passagem de gases e vapores permitindo a respirabilidade da pele. E a visualização de sítios de inserção sem remocação	Alérgico a componentes	

13.2 PREPARO DA SALA

TIPO DE CURATIVO	ATIVIDADES DE PREPARO	MATERIAIS NECESSÁRIOS	RESULTADOS ESPERADOS
Feridas Limpas (curativos)	✓ Preparar o ambiente; ✓ Realize a lavagem das mãos com água e sabão antes e após a realização de cada curativo mesmo que seja num mesmo cliente; ✓ Utilizar somente material esterilizado (gaze, pinças, tesouras e etc.) ✓ Reúna todo o material; ✓ Trocar lençol descartável da maca; ✓ Receber cordialmente o cliente; ✓ Orientar o cliente sobre o procedimento; ✓ Promova a privacidade do paciente fechando a porta; ✓ Colocar o cliente em posição confortável expondo a área a ser tratada; ✓ Calce as luvas de procedimentos; ✓ Abrir o pacote descartável de curativo com técnica asséptica; ✓ Se necessário abrir pacotinhos de gazes e colocar no espaço livre do campo evitando desperdício; ✓ Retirar o curativo anterior (se houver), com uma pinça dente-de-rato ou luva de procedimento, podendo molhar o curativo com soro fisiológico; ✓ Desprezar o chumaço de gaze e curativo contaminado na lixeira de lixo hospitalar e pinça dente de rato em um recipiente com tampa;	✓ 1 KIT estéril de curativo com 3 pinças ✓ Gaze estéril (quantidade de acordo com o tamanho e tipo de curativo); ✓ Bandeja ou cuba rim (opcional); ✓ Luva de procedimento; ✓ Solução fisiológica (SF 0,9%); ✓ Fita adesiva (esparadrapo ou fita adesiva hipoalergênica); ✓ Atadura de crepom se necessário;	✓ Promover meio ótimo para cicatrização; ✓ Manter ambiente e técnica ideal para a reparação tecidual; ✓ Prevenir infecção local; ✓ Assegurar a tranquilidade e conforto do paciente.

	✓ Limpar a ferida com a pinça Kelly e um chumaço de gaze embebida em solução fisiológica, seguindo o princípio da técnica asséptica (do menos para o mais contaminado). Utilizar quantos chumaços umedecidos em soro fisiológicos forem necessários; ✓ Observar: cor, umidade (secreção) e maceração ao redor da ferida, evasão e condições das mesmas; ✓ Secar toda a área adjacente com gaze seca para facilitar afixação do adesivo, renovando os chumaços de gaze conforme a necessidade, seguindo o mesmo princípio da técnica asséptica; ✓ Aplicar a solução de barreira padronizada, em spray;(vide obs 1) ✓ Aplicar a substancia tópica padronizada e ocluir a ferida; (vide obs 2) ✓ Colocar data e hora da realização do curativo, após oclusão; ✓ Lavar as mãos; ✓ Fazer registro do curativo e da evolução do processo de cicatrização para acompanhamento da ferida, presença de secreção e drenagem se houver (vide obs 3); ✓ Fazer orientações ao cliente e /ou família; ✓ Organizar a sala	✓ Frasco de álcool a 70 %; ✓ Solução de barreira em spray; ✓ Mesa auxiliar; ✓ Lixeira com saco branco leitoso; ✓ Lixeira com saco preto.	
	✓ Preparar o ambiente; ✓ Realize a lavagem das mãos com água e sabão antes e após a realização de cada curativo mesmo que seja num mesmo cliente; ✓ Utilizar somente material esterilizado (gaze, pinças, tesouras e etc.) ✓ Reúna todo o material;	✓ 1 KIT estéril de curativo com 3 pinças ✓ Gaze estéril (quantidade de acordo com o	✓ Estabelecer rotinas de execução de procedimentos de limpeza de feridas

Curativo contaminado	✓ Trocar lençol descartável da maca; ✓ Receber cordialmente o cliente; ✓ Orientar o cliente sobre o procedimento; ✓ Promova a privacidade do paciente fechando a porta; ✓ Colocar o cliente em posição confortável expondo a área a ser tratada; ✓ Calce as luvas de procedimentos; ✓ Abrir o pacote descartável de curativo com técnica asséptica; ✓ Se necessário abrir pacotinhos de gazes e colocar no espaço livre do campo evitando desperdício; ✓ Retirar o curativo anterior (se houver), com uma pinça dente-de-rato ou luva de procedimento, podendo molhar o curativo com soro fisiológico; ✓ Desprezar o chumaço de gaze e curativo contaminado na lixeira de lixo hospitalar e pinça dente de rato em um recipiente com tampa; ✓ Trocar as luvas de procedimento por outro par ou por luvas estéreis se necessário; ✓ Limpar a ferida com a pinça Kelly e um chumaço de gaze embebida em solução fisiológica, e solução degermante, seguindo o princípio da técnica asséptica (do menos para o mais contaminado). Utilizar quantos chumaços umedecidos em soro fisiológicos forem necessários; ✓ Observar: cor, umidade (secreção) e maceração ao redor da ferida, evasão e condições das mesmas; ✓ Avaliar se as feridas têm a necessidade de desbridamento de tecidos inviáveis:	tamanho e tipo de curativo); ✓ Bandeja ou cuba rim (opcional); ✓ Luva de procedimento; ✓ Solução fisiológica (SF 0,9%); ✓ Clorexidina degermante; ✓ Fita adesiva (esparadrapo ou fita adesiva hipoalergênica); ✓ Atadura de crepom se necessário; ✓ Frasco de álcool a 70 %; ✓ Cobertura ou correlato escolhido; ✓ Mesa auxiliar; ✓ Lixeira com saco branco leitoso; ✓ Lixeira com saco preto.	evitando infecções

	Se sim: Realizar a retirada de tecido inviável, como necrose e tecidos desvitalizados, com auxílio de pinça de preensão e lâmina de bisturi; Se não: preparar o tecido inviável de difícil retirada para desbridamento posterior com uso de solução emoliente ✓ Secar toda a área adjacente com gaze seca para facilitar afixação do adesivo, renovando os chumaços de gaze conforme a necessidade, seguindo o mesmo princípio da técnica asséptica; ✓ Aplicar a solução de barreira padronizada, em creme ;(vide obs 1) ✓ Aplicar a cobertura ou correlato escolhido e ocluir a ferida; (vide obs 2) ✓ Colocar data e hora da realização do curativo, após oclusão; ✓ Lavar as mãos; ✓ Fazer registro do curativo e da evolução do processo de cicatrização para acompanhamento da ferida, presença de secreção e drenagem se houver; (vide obs 3) ✓ Fazer orientações ao cliente e /ou família; ✓ Organizar a sala		

14. ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALIDADES

14.1 ANGIOLOGISTA

Os pacientes que necessitarem de angiologista deverão ser encaminhados pelo sistema, e devem seguir ser avaliados de acordo com perfil descrito no **ANEXO 3.**

14.2 NUTRICIONISTA

Os pacientes com necessidade de avaliação e acompanhamento nutricional que possuem área de abrangência, deverão ser agendados na unidade que estão lotados os profissionais, com encaminhamento de referência.

Região	Unidade Básica	Telefone
Região 1	Garavelo Parque	(62)3578-3861
Região 2	Anhembi	(62)3545-6508
Região 3	Veiga Jardim	(62)3545-4849
Região 4	Parque Trindade I	(62)3273-4608

Obs.: os pacientes deverão sair com agendamento (data, horário e local da consulta) com Nutricionista da unidade de origem, para unidade de destino.

Os pacientes que não possuem área de cobertura da Estratégia Saúde da Família o encaminhamento deverá seguir o fluxo pelo sistema de Regulação Municipal (Aparecidages).

14.3 REFERÊNCIA DE TRATAMENTO DE FERIDAS PARA GRUPO DE ASSISTÊNCIA A CURATIVO (GAC)

O Grupo de Assistência a Curativo (GAC) é um grupo de apoio para os profissionais das unidades de saúde para tratamento de feridas. E contará com Enfermeiro Estomaterapeuta, Nutricionista e Gestores de caso.

- O Gestor de caso é o enfermeiro assistente da unidade de saúde que poderá acionar enfermeiro Estomaterapeuta, quando julgar necessário consultoria pelo email:gacsmsaparecidadegoiania@gmail.com
- O enfermeiro assistente deverá imprimir a ficha do prontuário eletrônico com a avaliação da ferida, conforme ferramenta TIMERS (item 9.0) (preferencialmente com fotografia) para facilitar a avaliação, no assunto colocar o nome da unidade (não serão respondidos e-mails pessoais que não forem das unidades de saúde de Aparecida de Goiânia);

- O Estomaterapeuta por sua vez, receberá a demanda por e-mail e responderá em 72 horas com as orientações adequada e/ou encaminhamento para a central de referência em curativo e/ou quando necessário, agendará visita e/ou teleconsultoria com o enfermeiro gestor do caso em data e horário marcado com a presença do paciente na unidade para discutir caso;
- Os pacientes que por decisão da equipe necessitar de avaliação e/ou acompanhamento nutricional ou outra especialidade deverá seguir o fluxo conforme item 14.1 e 14.2.

14.4 ENCAMINHAMENTO PARA REFERÊNCIA DE CURATIVO

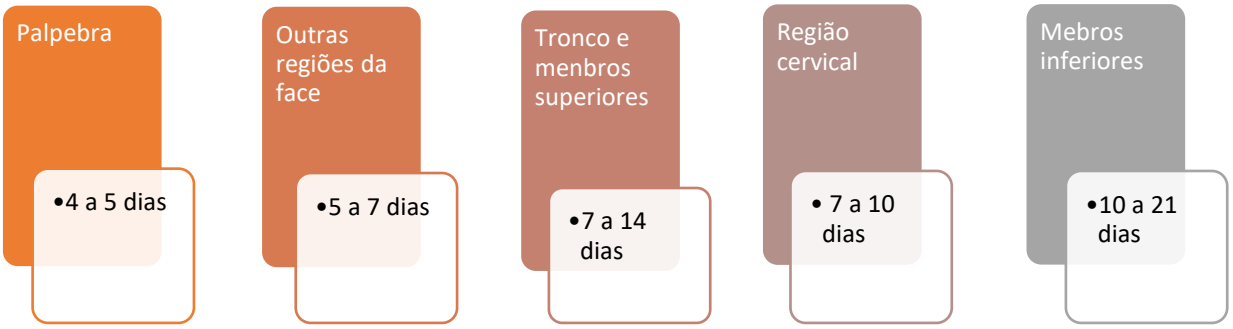
Os encaminhamentos para a referência de tratamento de feridas (CURACENTER) será para feridas em estágio IV (item 5.1). Assim o enfermeiro gestor do caso deverá enviar para equipe do GAC realizar avaliação (item 14.3) que por sua vez poderá contrarreferenciar para unidade de origem com as devidas orientações ou endossar o encaminhamento para referência (o estomaterapeuta será o responsável de enviar o lançamento do encaminhamento no sistema do AparecidaGES para a referência de curativo) conforme **ANEXO 1.**

15. RETIRADA DE PONTO

A literatura não traz dias precisos para retirada de pontos, no entanto a avaliação clínica com fatores sistêmico e o local da incisão influencia a cicatrização e o momento de retirada de ponto é importante avaliar alguns fatores:

- A obediência da sutura;
- As linhas da força;
- Fluxo sanguíneo (quanto mais longe do centro do corpo, maior tempo para cicatrização).

SUGESTÕES DE DIAS PARA RETIRADA DE PONTO

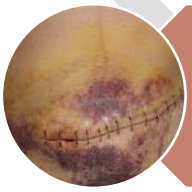


Adaptada ao procedimento da atenção primária (UNASUS, 2018)

15.1 Complicações

As complicações mais comuns de sutura é a deiscência, reação a corpo estranho, hematomas e seromas.

A **deiscência** consiste no afastamento das bordas e pode estar associado com infecção ou hematoma. O tratamento ocorre oi ressíntese ou cicatrização por segunda intenção com curativos diários



Hematomas consistem em coleções sanguíneas que podem surgir no período pós-cirúrgico, normalmente em conjunto com infecção e deiscência de ferida. Avaliação do cirurgião é necessário para avaliar uso de medicamentos e curativos diários.

Reação a corpo estranho pode estar associado a fios de nylon ou presença de corpo estranho. O tratamento consiste na eliminação do corpo estrano.

16. PERFIL DE FERIDAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE

A unidade de saúde realizará o atendimento e acompanhamento dos pacientes, conforme quadro abaixo:

FERIDAS	TIPO	CONDUTA DA EQUIPE
Traumática	Incisiva (perda mínima de tecido)	Atendimento e acompanhamento na unidade básica
	Grandes queimados, lesão química e Excisivas (remoção de pele)	Acionar GAC
Cirúrgica	Retirada de ponto	Atendimento na unidade
	Incisivas e Excisivas	Atendimento e acompanhamento na unidade de saúde
Ulcerativa	Estágio I, II, III	Atendimento na unidade
	Estágio IV	Realizar primeiro e atendimento Acionar GAC

16. UNIDADES QUE ESTÃO APTAS A REALIZAR ATENDIMENTO

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Endereço	Fone
UBS Alto Paraíso	Rua Cabo Frio C/ Rua São Félix C/ Rua Santa Ana APM 5, Jardim Alto Paraíso.	3296-7715 /3296-8815
UBS Bandeirantes	Rua Amador Bueno com Rua Pascoal Moreira Cabral C/ 2ª Avenida, Setor Bandeirantes.	3578-5429 / 3578-5489
UBS Caraíbas	Avenida Domitília Lobo, Qd 26,Lt 13, Residencial Caraíbas.	3288-0357 / 3288-6110
UBS Garavelo Park	Rua 36-E, Quadra 106 APM-1C, Garavelo Residencial Park.	3578-3861
UBS Buriti Sereno	Praça Marechal Hermes C/ Rua Pedro Américo Qd. 306 – Jd. Buriti Sereno.	3258-4154
UBS Bairro Cardoso	Av. Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II.	3288-1887
UBS Bairro Ilda	Rua José Bernardes de Sousa, Qd 33, Lt 07, Bairro Ilda.	3594-8722
UBS Cruzeiro do Sul	Rua do Canavial, Qd 03, APM 06, Conj.Cruzeiro do Sul.	3277-8616
UBS Delfiore	Rua Péricles Ramos, Qd 16, Lt 34, Vila Delfiori.	3545-9455
UBS Anhambi	Rua A,2, Q. 05, APM 03, Residencial Anhembi.	3545-6508
UBS Tiradentes	Avenida 8 esquina c/ a Rua 11, APM-16, Jardim Tiradentes.	3545-4840
UBS Boa Esperança	Rua C-48, APM -01, Jardim Boa Esperança.	3537-5284
UBS Campos Elísios	Rua La Rochelle, Qd. 50 APM-06, Campos Elísios.	3545-6047
UBS Jardim Florença	Rua Verona Qd. 22, Lt 01/ 20 Esq. C/ Rua São Paulo – Jardim Florença.	3545-4834 / 3537-3518
UBS Independência Mansões	Rua 56 Q. 125, Lt. 09 -18 – Setor das Independência Mansões	3545-6552
UBS Riviera	Rua Alberto Pasqualini C/ Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira, APM 07, Qd 31 FR, Lt 19, Setor Jardim Riviera.	3280-3529
UBS Andrade Reis	Avenida dos Girassóis, APM 03, Quadra 11, Setor Andrade Reis.	3545-5826
UBS Colina Azul	Rua das Garças S/N, Bairro Colina Azul.	3248-0219
UBS Santo André	Rua 24 de outubro, APM-18, Setor Santo André.	3283-5286
UBS Cândido de Queiroz	Rua 20 Q. 28 APM 07 – Res. Cândido de Queiroz.	3549-7585 /3549-6642
UBS Mansões Paraíso	Rua J-50 e Avenida W-1 Q. 65, Lts. 19/20 – Mansões Paraíso.	3545-9440
UBS Pontal Sul I	Avenida Anchieta c/ Rua Hematita, Q. 6B L.02, Pontal Sul.	3283-1678
UBS Pontal Sul II	Rua do Rodeio, Qd. 49, Lotes 01, 02 e 03, Pontal Sul – Acréscimo.	3545-4837
UBS Porto das Pedras	Rua R-1 Área Pública 01, Porto das Pedras 3545- 9430.	3518-4474 / 3545-9430

UBS Parque das Nações	Av. Argélia, Qd K01, Lt 21, Bairro Independência.	3545-9909
UBS Veiga Jardim	Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão – S/N Área Pública.	3545-4849
UBS Papillon Park	R. J, 16 - Quadra 494, Lote 10 - Papillon Park.	3545-4830
UBS Santa Luzia	Av. W-5, Qd 13, Lt 16, Jd. Olímpico.	3545-4701
UBS Rosa dos Ventos	Rua Dimitry Novgorodcev, APM-05, Setor Rosa dos Ventos.	3584-8214
UBS São Pedro	Rua 5, Chácara nº314, Chácaras São Pedro.	3545-5250
UBS Expansul	Avenida Coronel Eduardo Augusto de Barros, Área- E,Setor Expansul.	3545-6556
UBS Jardim Olímpico	Avenida Monte Carlo, Qd 28, Jardim Olímpico.	3282-0148
UBS Parque Trindade	Alameda Wilton Pinheiro, Quadra 25, APM-05, Parque Trindade.	3273-4608
UBS Nova Olinda	Av Independência, Qd 14, Lt 03, Jardim Nova Olinda.	3545-6029
UBS Retiro do Bosque	Rua das Paineiras, C/Rua Jacarandás APM – 4, Retiro do Bosque.	3280-9162
UBS Jardim dos Ipês	Rua JI 51, Qd 202, Lt 35/36, Residencial Jardim dos Ipês.	3578-9027
UBS Madre Germana	Rua MG 17, Área Verde, Madre Germana I.	3258-9961

17. FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CURATIVOS

A sala de curativo de deverá funcionar no horário de funcionamento da unidade de saúde com divisões de horários de curativos limpos e contaminados, e os horários deverão ser padronizados com de outras unidades, permitindo ao previsionamento de rotina.

a) **Estéril**: Curativo realizado na unidade de saúde, com material estéril (pinças ou luvas), solução fisiológica 0,9% aquecida e cobertura estéril.

b) **Limpa:** Curativo realizado no domicílio, pelo usuário e/ou familiar. Realizado com material limpo, água corrente ou soro fisiológico 0,9% e cobertura estéril.

c) **Contaminado:** curativo com necessidade de cobertura especiais e feridas com presença de infecções e exsudatos

As salas de curativos terão funcionamento padronizados das 08:00 ás 16:00 com horários distintos para curativos limpos e contaminados.

- Manhã: curativos limpos
- Tarde: curativos contaminados

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente protocolo visa apoiar o profissional na tomada de decisão, bem como ofertar qualidade no atendimento com tecnologias e técnicas adequada.

Ressaltamos ainda, que novas tecnologias podem ser inseridas ou suprimidas conforme evidências científicas disponíveis, sem aviso prévio.

NGC

	Nome	cargo	Área de Atuação
Elaboração	Suzana Angélica Santos Pereira	Enfermeira	SAS
	Hérica Souza Leguizamon	Coordenadora	NGC
Revisão	Penélope Bueno Fagundes	Chefia de	
Aprovação	Gustavo Assunção Amoury	Superintendente	SAS
	Colaboradores		
	Edmila Lucas de Lima	Enfermeira	Assistência Farmacêutica
	Geovane Melo	Diretor	SAS
	Willian Rabello Mendes	Apoio Técnico	Comunicação

Sugestão de melhoria: governancasmsaparecida@gmail.com

NGC

REFERÊNCIAS

SMANIOTTO, Pedro et al. **Sistematização de curativos para o tratamento clinico das feridas.** Revista Brasileira de Cirurgia plástica, dezembro 2012.

APARECIDA DE GOIÂNIA. **Relação de Materiais Médicos Hospitalares-REMAT.** Coordenação de Assistência Farmacêutica. Aparecida de Goiânia, 2023.

SÃO PAULO. **Manual de Padronização de Curativos**. Secretaria Municipal de Saúde. Janeiro de 2021.

OLIVEIRA, M, F et al. **Feridas em membros inferiores em diabéticos e não diabéticos: estudo de sobrevida**. Revista Gaúcha Enfermagem V. 40, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Condutas para Ulceras Neurotróficas e Traumáticas**. Secretaria de Políticas de Saúde. Brasilia, 2002.

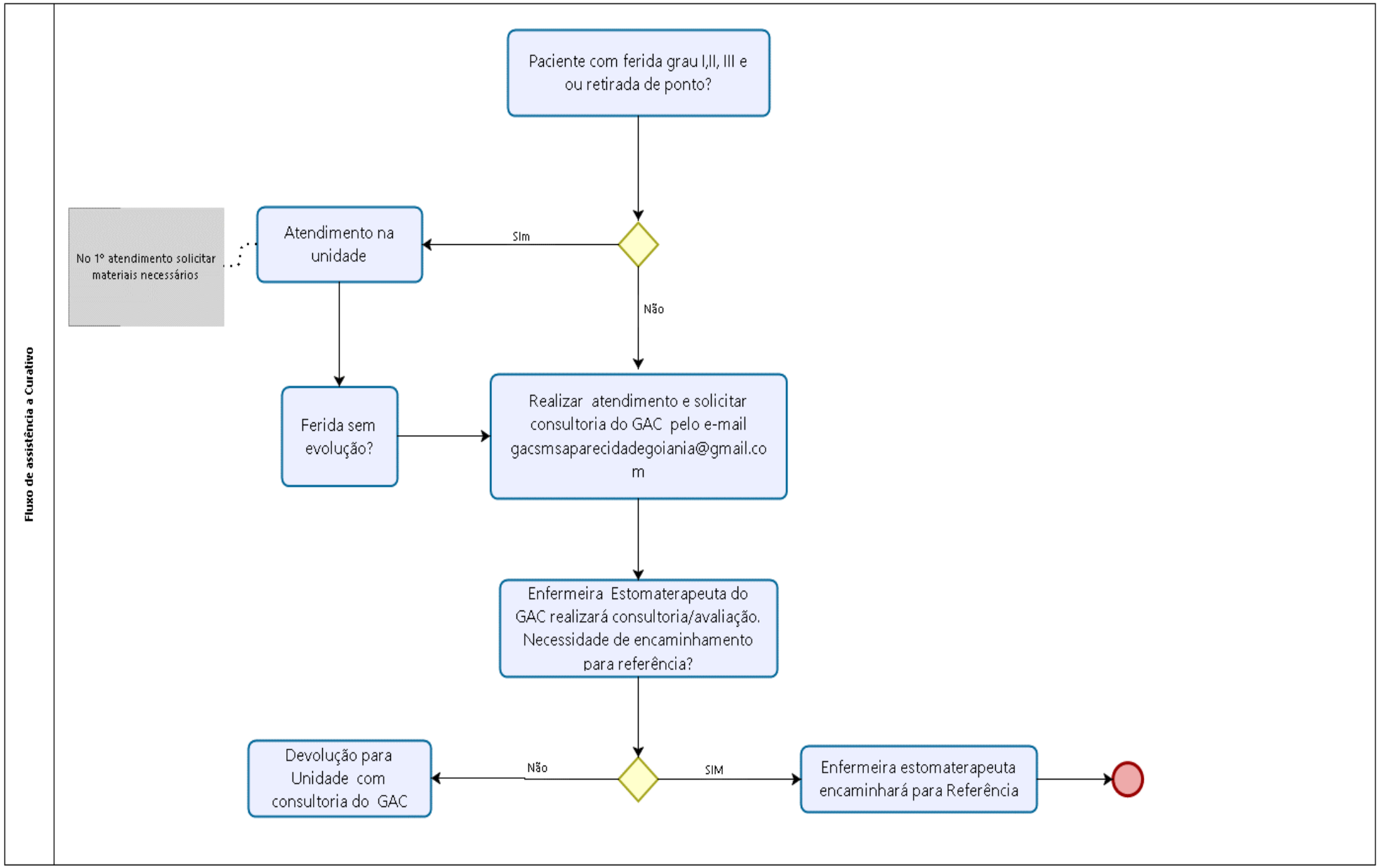
SIBBALD, et al**. Clinical Management. Increase Bacterial Burden and Infection:The Story of NERDS and STONES.**Woundcare Journal. Florida. Outubro, 2008.

BRASIL. UNASUS. **Procedimento em atenção primária, 2018.** Unidade 1 a 3. Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, 2018.

FLORIANÓPOLIS**.** Secretaria Municipal de Saúde**. Apoio Matricial de Enfermagem no Cuidado a Pessoa com Ferida.** Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2021.

NGC

ANEXO 1


Fluxo de assistência a Curativo
Paciente com ferida grau I,II, III e ou retirada de ponto?
Sim
Atendimento na unidade
No 1º atendimento solicitar materiais necessários
Não
Ferida sem evolução?
Realizar atendimento e solicitar consultoria do GAC pelo e-mail gacsmsaparecidadegoiania@gmail.com
Enfermeira Estomaterapeuta do GAC realizará consultoria/avaliação. Necessidade de encaminhamento para referência?
Não
Devolução para Unidade com consultoria do GAC
SIM
Enfermeira estomaterapeuta encaminhará para Referência

ANEXO 02

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE FERIDAS

PREFEITURA DE APARECIDA

HISTÓRICO

Tipo de ferida: ( ) Aguda ( ) Crônica Tempo:

( ) Cirúrgica ( ) Traumática ( ) Ulcerativa ( ) Queimadura

Tratamentos anteriores: _____

Recidivas: ( )Sim ( )Não Frequência da recidiva: _____

Alergias: ( )Não ( )Sim Quais? _____

FATORES DE RISCO

DM ( ) HAS ( ) Neoplasias ( ) Doenças Vasculares ( ) Outras ( ) _____

MEDICAMENTOS: ( ) Não ( ) Sim Qual:_____ TABAGISMO: ( ) Sim ( ) Não
Quanto por dia: _____

NUTRIÇÃO: ( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Desnutrido HIGIENE: ( ) Boa ( ) Ruim ( ) Péssima

MOBILIDADE: ( ) Total/Dependência ( ) Parcial ( ) Independente ( ) Acamado ( ) Cadeira de rodas

AVALIAÇÃO DA FERIDA

T

CARACTERÍSTICA DO TECIDO
( ) Necrose ( ) Granulação ( ) Epitelização ( ) Esfacelo
( ) Desvitalização ( ) Outro _____

I

PRESENÇA DE INFECÇÃO
( ) Limpa ( ) Contaminada ( ) Infectada

M

CARACTERÍSTICA DO FLUÍDO
( ) Seroso ( ) Sanguinolento ( ) Serossanguinolento
( ) Seropurulento ( ) Purulento ( ) Fibroso ( ) Nenhum

QUANTIDADE DE FLUÍDO
( ) Nenhum ( ) Pouco ( ) Médio ( ) Grande

E

CARACTERÍSTICA DA BORDA
( ) Indistinta ( ) Aderida ( ) Não Aderida ( ) Macerada
( ) Espessada ( ) Fibrótica ( ) Hiperqueratose
Comprimento_____ cm Largura_____ cm

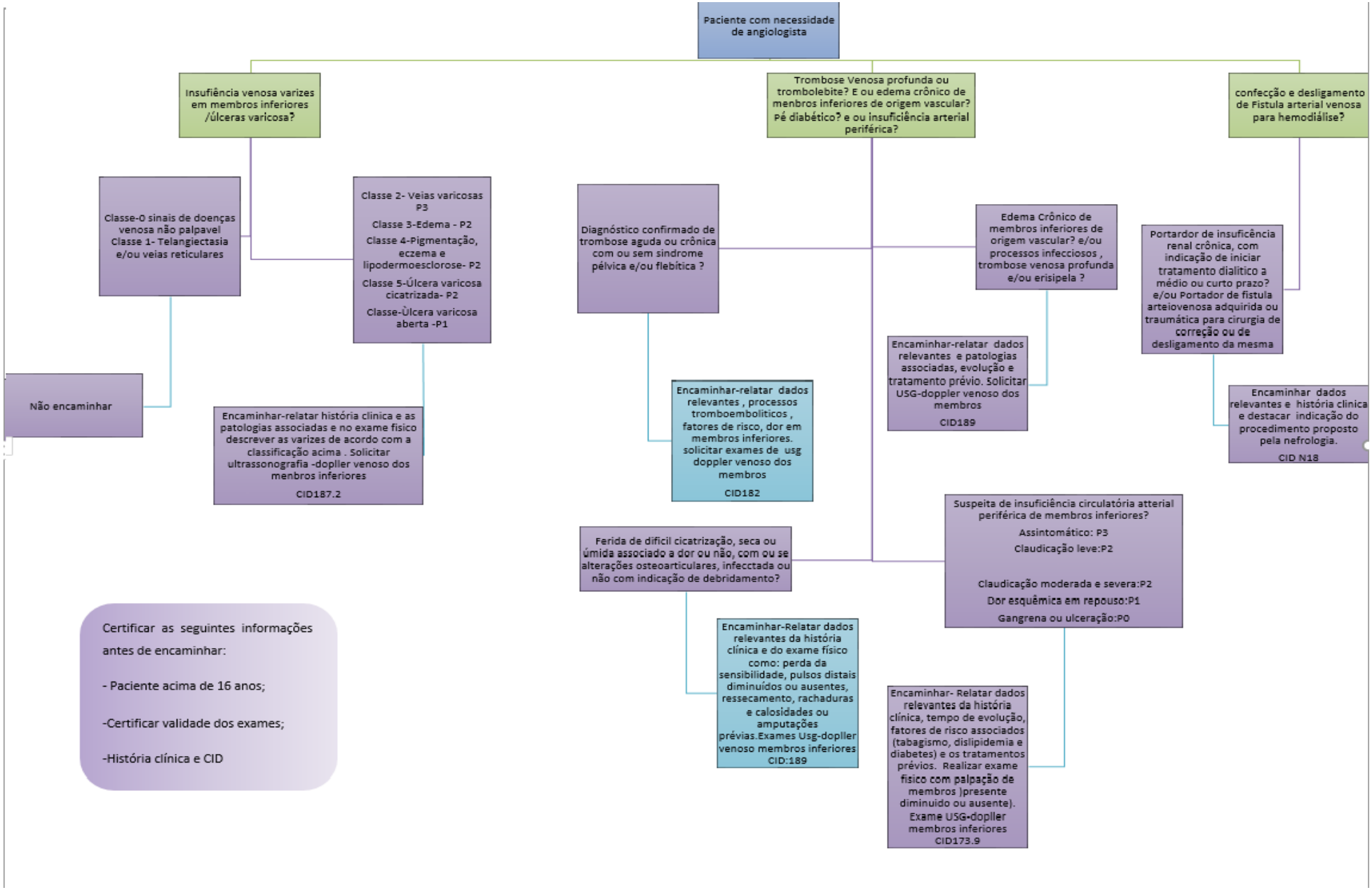
RS

FATORES SOCIAIS
Paciente em vulnerabilidade social?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, descreva_____

CONDUTA

( ) Colagenase c/ Clorafenicol (0,6 UI - 30g) ( ) Colagenase 1,2 UI - 30g
( ) Creme de barreira (protetor cutâneo em creme) - 60 ml ( ) Hidrocolóide - placa - 15x15cm
( ) Alginato de cálcio - placa - 15x15cm ( ) Carvão ativado c/ prata - placa - 10x10cm
( ) Hidrofibra c/ prata - placa - 15x15cm - Aquacel Ag+ ( ) Protetor cutâneo - spray - Frasco 28ml
( ) Hidrogel sem Alginato de Cálcio 85g ( ) Hidrogel c/ Alginato de Cálcio 85g
( ) Sulfadiazina de prata 1% 30g ( ) AGE - Frasco 200ml

PREFEITURA DE APARECIDA

SECRETARIA DE SAÚDE SUS

ANEXO 3